HagaZiekenhuis

Varicocèle

Spatader in de balzak

Tijdens uw bezoek aan de polikliniek Urologie heeft uw behandelend uroloog vastgesteld dat u een varicocèle heeft, een spatader in de balzak. De uroloog heeft met u besproken hoe de varicocèle behandeld kan worden. Dit kan op twee manieren: via een operatie of een embolisatie. De radioloog doet de embolisatie op de röntgenafdeling. Deze folder geeft u informatie over de operatie, de voorbereiding en de nazorg. Ook embolisatie komt kort aan de orde.

Wat is een varicocèle?

In het scrotum zitten 2 testikels met 2 bijballen die aan de testikel vast zitten. Deze zijn verbonden met de zaadleider, die richting het lieskanaal gaat. Samen met deze zaadleider lopen er bloedvaten van en naar de testikel, via het lieskanaal. Een varicocèle is een uitzetting van de bloedvaten die tussen het lieskanaal en de testikel zit. Het is dus eigenlijk een soort spatader in de balzak.

In 90% van de gevallen zit de varicocèle links. Dit komt omdat het bloedvat van de testikel (vena spermatica) uitmondt in het bloedvat van de nier (vena renalis) aan de linker kant. Als de klepjes in het bloedvat niet meer voldoende werken, ontstaat er een spatader. Het bloed stroomt dan door hoge druk terug richting de testikel. De meeste varicocèles geven geen klachten. Ze worden vaak bij toeval ontdekt tijdens een lichamelijk onderzoek.

De oorzaak van een varicocèle is niet helemaal duidelijk. Meestal is er geen onderliggend lijden. Maar bij een plotseling ontstane varicocèle op oudere leeftijd of bij een varicocèle aan de rechter kant moet er verder onderzoek gedaan worden. Het onderzoek van een varicocèle bestaat uit een lichamelijk onderzoek en een echografie. Dit is een onderzoek met geluidsgolven. De spatader is duidelijker te zien als u staat dan wanneer u zit. Bij drukverhoging kan de zwelling toenemen.

15% van de mannelijke bevolking heeft een varicocèle. Van mannen met verminderde zaadkwaliteit of vruchtbaarheidsproblemen heeft 20 - 40% een varicocèle. Door de aanwezigheid van spataderen kan de temperatuur in de balzak hoger worden. Dit kan leiden tot een verminderde zaadkwaliteit. Vaak wordt gedacht dat een varicocèle de oorzaak is van mannelijke onvruchtbaarheid. Dat is niet het geval. Bij deze patiënten kan een behandeling van de varicocèle mogelijk wel een verbetering van de kwaliteit van het sperma opleveren. Diverse onderzoeken leveren nog geen duidelijke conclusie.

Wanneer wordt een varicocèle behandeld?

Een varicocèle wordt alleen behandeld als de varicocèle klachten geeft. Ook als de man ongewenst kinderloos blijft en een afwijkende zaadproductie blijkt te hebben, kan de man als hij dat wenst, worden behandeld.

Welke behandelingen zijn er?

De behandelingen hebben als doel het defecte bloedvat buiten werking te stellen door het dicht te binden.

Operatie

Tijdens een operatie zoekt de uroloog via een klein sneetje in de onderbuik de bloedvaten op en bindt deze af. Het sneetje kan ook worden gemaakt in de lies of in het scrotum (balzak). De ingreep gebeurt in dagbehandeling. In overleg met de anesthesist krijgt u een ruggenprik of een volledige narcose.

Embolisatie

Het is ook mogelijk om via radiologische technieken de spatader zichtbaar te maken met contrastvloeistof. De radioloog schiet dan een afsluitend veertje in de spatader zodat het afsterft. De kans op succes van deze behandeling is ongeveer 80%. Voor deze behandeling krijgt u een plaatselijke verdoving via een prik in de lies.

Zijn er complicaties na de behandeling?

Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, pijn in het wondgebied of een infectie. Een blauwverkleuring van de wond komt vaak voor. Hier is geen verdere behandeling voor nodig. Als reactie op de operatie kan er ook een hydrocèle ontstaan. Dit is een goedaardige zwelling van de balzak. Er zit dan extra vocht rondom de testikel. Bij een operatie wordt namelijk een deel van de bloedtoevoer afgesloten. Daardoor kan er atrofie van de testikel ontstaan. De bal wordt kleiner, verschrompelt of sterft af.

Waar moet u thuis op letten?

- De hechtingen lossen vanzelf op
- Een dag na de operatie mag u weer douchen
- Na 14 dagen is zwemmen meestal weer mogelijk
- De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. U voelt meestal zelf het beste wat u wel en niet kunt

Gebruikt u bloedverdunners?

Als u bloed verdunnende middelen gebruikt, moet u hier vaak vóór de operatie tijdelijk mee stoppen. Uw uroloog bespreekt dit vóór de operatie met u.

Wanneer is de controleafspraak?

Ongeveer 6 weken na de operatie heeft u een controleafspraak bij uw behandelend arts. Als u eerder problemen of vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Urologie.

Contactgegevens

De polikliniek Urologie is bereikbaar

- maandag tot en met vrijdag
- van 8.00 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur
- via telefoonnummer (070) 210 6482

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw uroloog.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

250510022025